

1. Datos del paciente

ID Paciente	P006
NHC	NHC-2021-007293
Nombre completo	Marta Esteve Climent
Sexo	Mujer
Fecha nacimiento	22/09/1985
Edad	40 años
DNI	73.412.658-R
Teléfono	654 231 098
Municipio	Vila-real
Médico responsable	Dr. Javier Soler Pascual
Especialidad	Psiquiatría

2. Antecedentes personales

- Trastorno depresivo mayor, episodio recurrente (diagnóstico 2019, CIE-10: F33.1)
- Trastorno de ansiedad generalizada (diagnóstico 2020, CIE-10: F41.1)
- Insomnio crónico asociado
- Hipotiroidismo subclínico (2022)
- Antecedente de ideación autolítica pasiva en 2021, sin tentativas previas
- No alergias medicamentosas conocidas

Antecedentes familiares: Madre: trastorno depresivo mayor y trastorno de ansiedad generalizada. Tía materna: intento de suicidio a los 45 años. Padre: trastorno por consumo de alcohol en remisión.

3. Historia clínica actual

Paciente de 40 años derivada desde Atención Primaria por empeoramiento clínico en las últimas 8 semanas. Refiere estado de ánimo deprimido persistente, anhedonia marcada con abandono progresivo de actividades sociales y laborales (baja laboral desde hace 3 semanas). Presenta insomnio de conciliación y despertar precoz (duerme aproximadamente 4 horas por noche), fatiga intensa durante todo el día, dificultad para concentrarse en tareas básicas y sentimientos de inutilidad y culpa excesiva. Pérdida de apetito con descenso ponderal de 5 kg en los últimos 2 meses. Niega ideación autolítica activa en el momento actual, aunque reconoce pensamientos recurrentes de que 'todo sería más fácil si no estuviera'. Concomitantemente, refiere preocupación excesiva e incontrolable por múltiples áreas de su vida (economía, salud de sus hijos, rendimiento laboral) desde hace más de 6 meses, acompañada de tensión muscular cervical, inquietud motora y dificultad para relajarse. El tratamiento previo con sertralina 100 mg se interrumpió por decisión propia hace 4 meses por mejoría parcial.

4. Exploración

Aspecto general	Consciente, orientada en las tres esferas. Aspecto descuidado, contacto visual escaso
Psicomotricidad	Enlentecimiento psicomotor leve. Latencia de respuesta aumentada
Estado de ánimo	Ánimo deprimido. Afecto constreñido con llanto fácil durante la entrevista
Pensamiento	Curso enlentecido. Contenido con ideas de inutilidad y culpa. Rumiaciones ansiosas. Sin ideación delirante

Sensopercepción	Sin alteraciones. Niega alucinaciones auditivas o visuales
Cognición	Atención disminuida. Concentración pobre. Memoria conservada
Juicio y conciencia de enfermedad	Juicio conservado. Buena conciencia de enfermedad. Solicita ayuda activamente
Riesgo autolítico	Ideación pasiva de muerte sin planificación. Sin intención ni plan estructurado
Peso / Talla / IMC	58 kg · 165 cm · 21,3 kg/m ²
Tensión arterial	118/72 mmHg
Frecuencia cardíaca	82 lpm, rítmica

5. Tratamiento actual

Fármaco	Posología
Escitalopram 15 mg	1 comp. en desayuno (inicio hace 2 semanas, pendiente de titular a 20 mg)
Mirtazapina 15 mg	1 comp. en cena (coadyuvante para insomnio y apetito)
Lorazepam 1 mg	1 comp. en cena si ansiedad intensa (uso puntual, máximo 4 semanas)
Levotiroxina 25 mcg	1 comp. en ayunas

6. Resultados de laboratorio

Parámetro	Resultado	Ref.	Estado	Previo
TSH	5,8 mU/L	0,4–4,0	Alto	4,2 mU/L
T4 libre	0,9 ng/dL	0,8–1,8	Normal	1,1 ng/dL
Hemograma	Normal	—	Normal	Normal
Glucosa	88 mg/dL	70–110	Normal	92 mg/dL
Cortisol (8h)	22,4 mcg/dL	6,0–18,0	Alto	—
Vit. B12	310 pg/mL	200–900	Normal	—
Ácido fólico	4,2 ng/mL	3,0–17,0	Normal	—
Perfil hepático	Normal	—	Normal	Normal

7. Plan de actuación

1. Titular escitalopram a 20 mg/día en 1 semana si buena tolerancia
2. Mantener mirtazapina 15 mg como coadyuvante; valorar aumento a 30 mg si persiste insomnio
3. Retirada progresiva de lorazepam en 4 semanas
4. Derivación a psicología clínica para terapia cognitivo-conductual (TCC) semanal
5. Control analítico de función tiroidea en 6 semanas
6. Plan de seguridad: contacto telefónico semanal las primeras 4 semanas. Derivar a urgencias si aparece ideación autolítica activa con plan
7. Revisión presencial en consulta en 3 semanas

AVISO: Todos los datos de este documento son completamente ficticios. Generado para el TFG: Sistema RAG de apoyo en salud mental.